

INDICADO POR: Vera Amaral

() ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

MARIA CONSUELO AMARALIDADE: 80PESO: 48ALTURA: 1,54PROFISSÃO: INSSProfessora (Aposentada)SINTOMAS: ao acordar sente peso na cabeça

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Deller / Clorazepata / Suenon / Divalina / AnxitecMÉDICO: Dr. Afonso Sá

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: Hidro 2x / Funcional 1-2xHORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5ALMOÇO: 5LANCHE: NJANTAR: 19:30-20hHORA QUE DORME: 23hHORA QUE ACORDA: 7h30

COCHILHO () S (X) N

DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N

/ DORMEM NO QUARTO: () S (X) N

PET NO QUARTO: () S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N

eventual

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasalBANHEIRO/NOITE: 0

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: Enfisema Pulmonar

MALLAMPATI:

IAH: 45clhSPO2: 69%PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Enfisema Pulmonar / artrose

CIRURGIAS: (X) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA

(N) NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

18/03/26 - Análise -

Exame

Nome MARIA CONSUELO AMARAL

Nascimento 16/11/1945 (79 anos)

Sexo Feminino

Início 10/11/2025 - 23:23:17

Tempo total 07:06:30 (426,5 min)

Fim 11/11/2025 - 06:29:47

Tempo válido 06:57:47 (417,8 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☒ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 10/11/2025

Peso 48 kg

Altura 1,54 m

IMC 20,2

Medicamentos

Respondido em 10/11/2025

- ☐ Nenhum
- ☒ deller, clorona, revani B, a

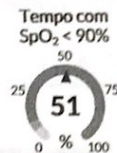
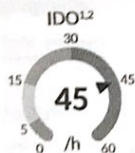
Sintomas Respondido em 10/11/2025

- ☐ Nenhum
- ☒ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☐ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☒ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 10/11/2025

- ☐ Nenhuma
- ☐ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☒ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☒ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

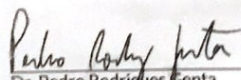
IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia realizado no dia 10/11/2025, iniciado às 23:23 e terminado às 06:29. O tempo total de registro foi de 7h06min (426 minutos) e o tempo válido foi de 6h57min (417 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 310 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 44,5/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 90% e permaneceu abaixo de 90% durante 51% do tempo de registro (216 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 69% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 44,5/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.



Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).

Às Mesas do Sono,

Examinado a paciente Maria
Paschoa Amoral, 80 anos, com boa
do humor sereno, pp avaliação e
conduta

Guato

27/12/25

Dr. Glauco T. Fernandes de Sá
CRM 46217 - SP